جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : زينب محمد مرسي حسن
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** الزيتون **العنوان :** ----------
رقم البطاقة : 25403240103429 **رقم التليفون :** 01013433693 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 11-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 24-03-1954 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج هرموني خط ثاني مثبطات الاروماتيز [14161] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: زينب محمد مرسي حسن
National ID: 25403240103429

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Second Line Hormonal Treatment Aromatase Inhibitor**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



زينب
محمد مرسى حسن
٢ ش مصيلحى بكر
الزيتون - القاهره

٢٩ ٠٣٤ ٠١ ٣٢٤ ٠٢٥٤

LM3088202

٢٩٠٣٤٠١٠٣٢٤٠٢٥٤ ٢٠٢٥/١/١
ربة منزل

انثى مسلمة متزوجة
نشات عبدالرؤف نافع احمد قايد
البطاقة سارية حتى ٢٠٣٢/١١/٢١

١

Patient Name	:		
Patient No.	: 25403240103429	Request No.	: 13005748
Path No.	: 2024/24	Request Date	: 12/06/2024
Sex	: Female	Verification Date	: 01/07/2024
Age	: 70 Y	Financial Category	: اورنج دار السلام - بنك الدولة
Referring Doc	:	Department	: Out Patient
		Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Bilteral breast cancer, post NACT.
Nature Specimen: Bilateral breast conservative surgery.

1-Gross Examination of Right BCS:
- Procedure: Right BCS

Fibrofatty tissue piece measured 7x5x2.5 cm with covering skin ellipse measured 5x5 cm.
- Tumor extent: A wired and clipped greyish white tumor bed site
- Size: 2.2x1.5x1 cm.
- Skin involvement: show fixed nipple.
- Distance from margins: 0.2 cm away from (medial margin)
- Right extra medial margin: Fibrofatty tissue peice measured 5x4 cm free for gross induration.
- Right SLNs: Fibrofatty tissue peice 4x3 entangling 3 LNs up to 1x1 cm.

2-Gross Examination of Left BCS:
Procedure: Left BCS

Fibrofatty tissue piece measured 8x6x2 cm with no skin cover.
- Tumor extent: Three wired greyish white tumor bed site
- Size: 0.4x0.4, 0.5x0.5, 0.8x0.8 cm.
- Skin involvement: show fixed nipple.
- Distance from margins: 1 cm away from (superior margin)
- Left extra deep : Fibrofatty tissue peice measured 4x3 cm free for gross induration.
- Left extra inferior: Fibrofatty tissue peice measured 4x2 cm free for gross induration.
- Left SLNs: Fibrofatty tissue peice 6x5 entangling 5 LNs up to 3.5x2 cm.

1-Microscopic Examination of Right BCS:
- Histological type: Residual viable invasive carcinoma. (Cellularity 10%)
- Ductal carcinoma in situ: No.
- Skin involvement: Free.

Verified by :
Dr. Sagda El-Kady

Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadima - Cairo, Egypt
غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر

Name: زينب محمد مرسي **MR. :** 4699	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

Ct4b , N2 Pyt came today for femara , supp tt for 3 mn DEXA scan 14-2-2026 >>> osteoprosis for dental consultaion for zometa CT CAP >>> R BSM 5-2025 >>> Free

Patient needs extraction of lower right remaining roots. Zometa is postponed and dental panoramic xray is requested.

5/2026:ct CAP splenic focal lesion presented since 2023 (cystic lesion) fatty hepatomegaly uterine lesions likely fibriods tday 18/5 /2026 for femara 2.5mg e supportive ttt then 3 months pharmacy.

Femara +supportive*3m ct :splenic focal lesion for mri ,,,req next visit :28/9/2026.

SM 15/8/2026 : NAD CT CAP 15/8/2026 : SD pt has splenic lesion 44x34mm (sd since 2023 no need for mri) for 3 month femara next visit 10/10.

تحريرا في ,

التاريخ :	**19-09-2026**	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : نهي سعيد علي محمد

يعتمد ,

Patient Name	: [illegible]	Request No.	: 13005748
Patient No.	: 25403240103429	Request Date	: 12/06/2024
Path No.	: 2024/24	Verification Date	: 01/07/2024
Sex	: Female	Financial Category	: [illegible]
Age	: 70 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

* Resection margins: Free margins & free extra medial margin.
* Histologic response to therapy: Partial pathological response.
* Microcalcifications: scattered microcalcification.
* Additional pathologic findings: Effect of therapy in the form of fibrosis, histocytic reaction and hyalinosis.
- Surrounding breast tissue showing scattered papilloma.
* Free SLNs (0/3).

2-Microscopic Examination of left BCS:
* Histological type:Residual multifocal invasive mixed ductal and lobular carcinoma. (Cellularity 70%)
* Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): Grade II (3+2+1)
* Ductal carcinoma in situ: 10% (solid and cribriform).
* Resection margins: Inferior margin showed extensive microcalcification, deep margin showed infiltrating tumor cells.
* Histologic response to therapy: Partial pathological response.
* Additional pathologic findings: Rest of the breast show effect of therapy in the form of (fibrosis, histocytic reaction and hyalinosis)
* SLNs: Free (0/5)

1-Diagnosis of Right BCS:
Right BCS, post NACT:
Residual invasive ductal carcinoma.
Free margins and free extra medial margin.
Partial pathological response.
Free SLNs (0/3).
Stage: ypT2, ypNO.
RCB: 1.55, RCB-II.

Verified by :
Dr. Sagda El-Kady

Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Cornicke - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name	: الأستاذة / زينب محمد يوسف		
Patient No.	: 26403240103429	Request No.	: 13005748
Path No.	: 2024/24	Request Date	: 12/06/2024
Sex	: Female	Verification Date	: 01/07/2024
Age	: 70 Y	Financial Category	: ارزام دار السلام - هيئة المرأة
Referreing Doc	:	Department	: Out Patient
		Registered by	: marwa mohamed yousa

Pathology Report

2- Diagnosis of left BCS:
Left BCS, post NACT:
Residual multifocal invasive mixed ductal and lobular carcinoma, Grade II.
Free margins, free extra inferior margin and extra deep margins.
Partial pathological response.
Free SLNs (0/5).
Stage: ypT1b, ypN0
- RCB: 1.843, RCB II class .

Signature
Dr. Marwa Mahmoud.
Dr. Sagda Elkady.

Verified by :
Dr. Sagda El-Kady

CAP Accredited
غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Women's Health Outreach Program

Name: zulnab Mohamed morsy
Date: 12-11-2023

Full field Bilateral Digital Mammography & ultrasonography

Clinical summary: pathological proved bilateral invasive duct carcinoma

Detailed Findings

Technique

Craniocaudally &Medio lateral oblique views
High resolution ultrasound

Right breast

- ACR density b
- Retroareolar focal asymmetry with nipple reaction
- U/S shows ill-defined retroareolar hypoechoic area at zone (a&b) measures about 5x3cm
- Enlarged two axillary LNs 13x4mm & 14x6mm with focal cortical thickening in both 4.8mm

Left breast

- ACR density b.
- Two ill defined UIQ small lesion away from each other by 22mm
- Ultrasound demonstrated two speculated small dense lesion one between 12-1 o'clock measures 7x5mm other between 11-12 o'clock measures 7x8mm
- Normal skin/nipple/areolar complex.
- Enlarged one pathological lymph node measures 15x9mm with focal cortical thickening 5mm

Conclusion:

-left breast: (BIRADS 6). Pathological proved two malignant lesions
-Right breast: BIRADS 6) Pathological proved retroareolar malignant lesion

DR Marwa M,Hassan

ت / فاكس ٠٢٢٣٦٤٥٨١٣
Tel, Fax: 0223645813
١٠٥٣ شارع كورنيش النيل ، أمام الخليج ، القاهرة
1053 Corniche El Nil St. Form Al Khaleeg , Cairo

Name: Zainab Mohamed Morsy
Date: 17/08/2023

Imaging Guided Clip localization:

Clinical summary: Known case of Bilateral invasive ductal carcinoma before receiving NACT.

Technique:

- Under complete sterile conditions, 3ml of local anaesthetic were administered at the site of concern in the LT breast and right breast .
- Three clips marker were inserted in the left multiple ill-defined irregular spiculated malignant proven mass lesion. Between 11-1 o'clock
- clip marker was inserted in the retroareolar malignant proven mass lesion.
- This confirmed by mammographic CC & ML

Dr Marwa M.Hassan

ت / فاكس ٠٢٢٣٦٤٥٨١٣
Tel, Fax:0223645813

١٠٥٣ ش كورنيش النيل . قم الخليج . القاهرة
1053 Corniche El Nil St. Fom Al Khaleeg, Cairo

Oncology
معهد الأورام

وزارة الصحة
إدارة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى معهد ناصر
Nasser Institute Hospital

الاسم: Zeinab Mohamed Moursy

التاريخ: 09/05/2024

Dynamic Contrast Enhanced MRI Study of the Breast:

Pulse Sequences:

Pre-contrast axial T1,T2 ,STIR and Sagittal T2WIs.

Post-contrast axial VIBE and Subtraction WIs.

Indication of the examination:

70 years old female patient complaining of both breast mass.

Report:

- Both breasts show mixed fibro glandular parenchyma (ACR B) with mild background enhancement.
- Statues post clips insertion for histopathological proving left invasive duct carcinoma shows three residual mass lesions , at upper central(12 o'clock measuring about4 mm) , and at upper outer (1 o'clock measuring about 5 mm) , (2 o'clock measuring about 4 mm) , exhibits intermediate signal on T1WIs , low signal on T2WIs , bright signal on fat sat images & restricted on DWIs, with heterogeneous contrast enhancement, on plotting time signal intensity curve ,it shows type III
- Bilateral reactionary non-specific axillary lymph nodes.
- Right breast showing no residual masses could be detected.
- Normal nipple areola complex of both breasts.

OPINION:

- Statues post clips insertion for histopathological proving left invasive duct carcinoma showing residual malignant looking breast mass as described above (BIRADS 6) .

DR. HEBA NABIL, MD

Women imaging Consultant

Tel: 2600164 2600156 Fax: 2600159

MDT form

A-Patient ID: 83168219
1- Name : Sex: Female 3- Medical number: Old Med #:
2-ID number: 2580324010342 Patient Age : 20 Y Date: 5/28/2023

MDT

0 0

Family history		Phone	01120260694	BMI		REASON OF MDT	
marital status		HRS Score		GROUP		Date of MDT	18/07/2024
Co morbidity	htn,dm,cardiac	Menopausal status		Initial STAGE			

Clinical data

Breast Imaging :
RT biopsy retro areolar suspicious for pagets & CT breast malignant mass lesion <5 suspicious axillary L.N

Mets Workup :
CT CAP c' contrast : free

BX	ER	PR	Her 2 Neu	SISH	KI67
IDC	7/8	7/8	0		10

T	N	M
right T4b left T1	right N1 left N1	0

Sonomammography
RT BREAST RETROAREOLAR 5 CM LESION (CLIPPED) , AXILLARY LN
LEFT BREAST 3 MASSES (CLIPPED), PATH AXILLA

PATIENT HISTORY
pt received AI for 4 months
NEW MRI BREAST REACTIVE AXILLARY LNS
RT BCS :residual IDC YPT2(2CM), N0/3
lt BCS: residual IDC & lobular
*YPT1b(MULTIFOCAL) YPN0/5

MDT OUTCOME & PLAN

1- ADJUVANT AROMATASE INHIBITOR
2- PORT

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY		RADIOLOGY	
SURGERY		PATHOLOGY	
Psychiatric		Nutrition	

مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

MDT FORM / /20 G B

Name	[illegible]	MRN	392812/23
		ID	
Age	70 y/f	Phone	01126260695
Menopausal status		Marital status	
NRS SCORE		Family history	sister : breast
BMI		REASON OF MDT	sister : uterus
CO morbidity	DM, HTN, Cardiac CA		

Clinical Data

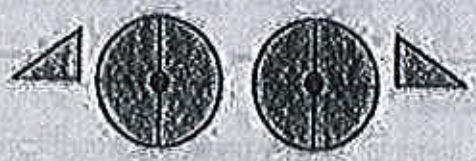
BX: IDC II.

ER:	PR:	HER 2:	KI67:
+ve	+ve	-ve	10%.

Sonomammography:

Mets Workup:

R L



TNM

Recommendations: Post- operative pathology:
Rt BCS : residual IDC, free margin, free extra margin, free SLN 0/3, ypT2, ypN0
Lt BCS : residual IDC & tubular, free margins
free extra SLN 0/5
ypT1b, ypN0

MDT OUTCOME & PLAN

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric

GUSTAVE ROUSSY

Patient Name: Zainab Mohamed Morsi Hassan	Date : 09/08/2025
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 71 Year(s)
Medical ID: 3928/2023	Pat. ID: 43227

BILATERAL MAMMOGRAM AND BREAST ULTRASONOGRAPHY REVEALED:

Indication: Follow up after bilateral conservative surgery.

- Breast density: Scattered de nsities of glandular tissue .. Matching ACR b .
- Bilateral thickened breast skin with operative bed related focal asymmetry .
- No detected definite suspicious masses, architectural distortion or pathological calcifications in both breasts .

By complementary bilateral breast ultrasound:

- Heterogeneous (predominantly fatty) parenchymal echo-texture.
- Bilateral thickened breast skin (4 mm)with underlying minimal interstitial edema.
- No detected suspicious solid or cystic masses in both breasts..
- No detected significant axillary lymph nodes.

CONCLUSION:

- Bilateral Post conservative changes(BIRADS 2 Category).

Much Obliged

DR.MONA ZAKY.MD

Professor of diagnostic radiology-Breast Imaging unit -Mansoura University

Signature Dr. Mona Zaki

09/08/2025 4:17 PM